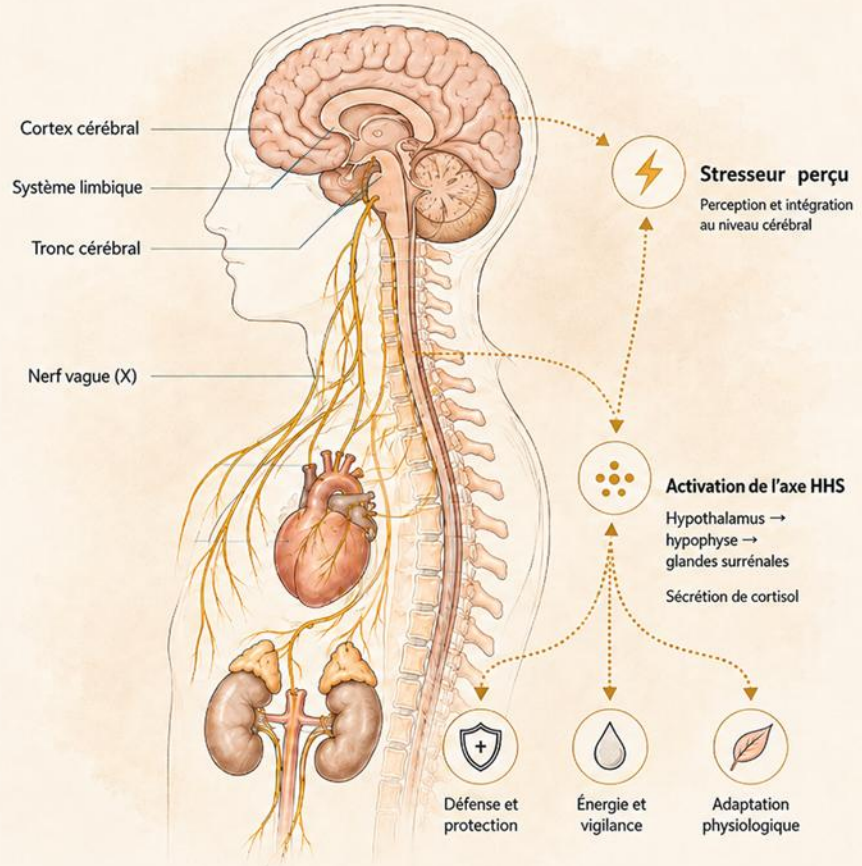


Chapitre 5

Mécanisme de stress

Coût allostatique
et approche ROP

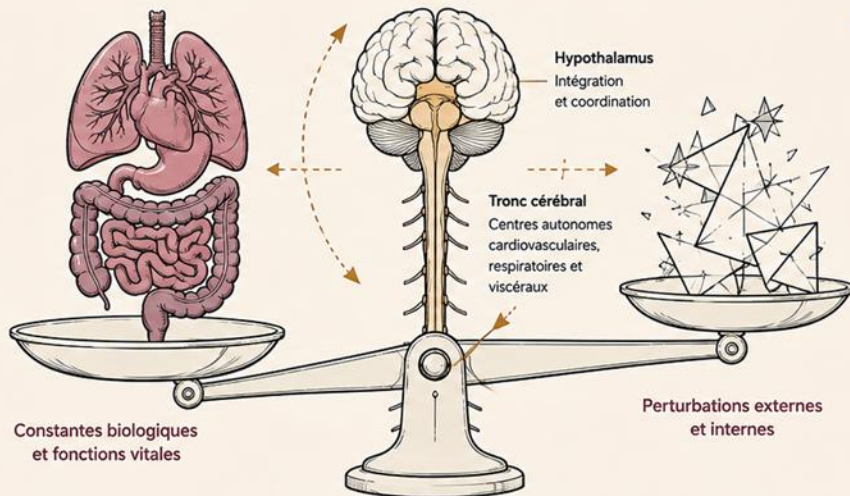


Homéostasie et Allostasie

Maintenir les constantes vitales, s'adapter au contexte pour préserver la stabilité.

Homéostasie

Maintenir les grandes constantes internes dans des limites compatibles avec la vie.



Allostasie

Préserver la stabilité en changeant provisoirement de fonctionnement. Réponse adaptative au contexte.



L'homéostasie n'est pas un état immobile : elle repose sur des corrections permanentes, le plus souvent invisibles.



Stress = forme d'allostasie

Mobilisation protectrice à court terme pour faire face à une contrainte.

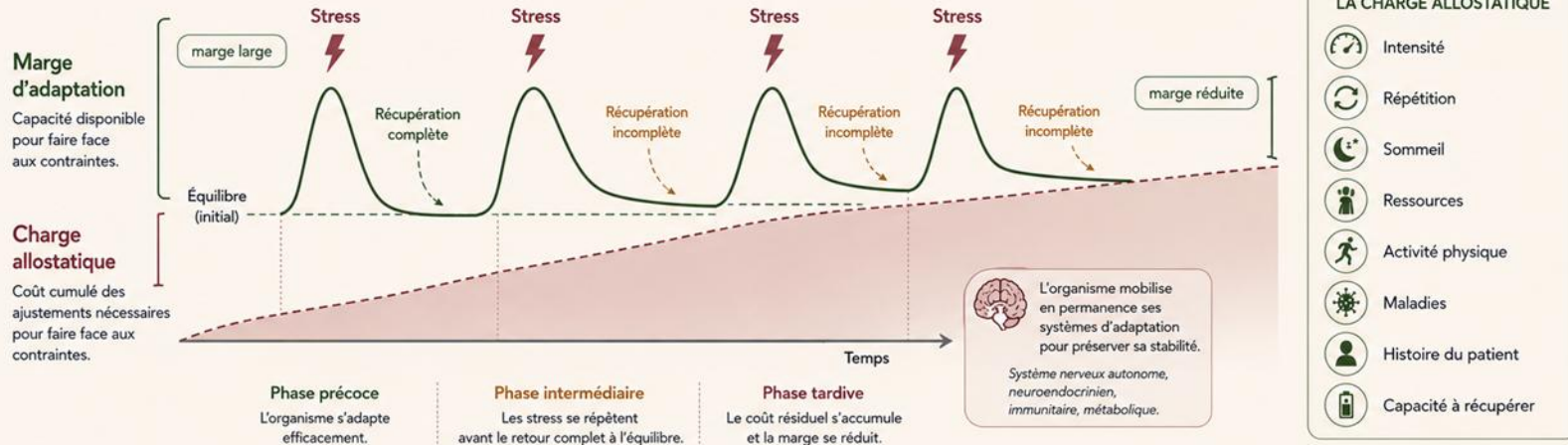


Quand l'adaptation persiste trop longtemps...

ou se répète trop souvent, ou perdure sans menace, le coût s'accumule : **charge allostatique**. La récupération devient insuffisante.

Charge allostatique : le prix cumulé de l'adaptation

Quand les contraintes s'accumulent plus vite que la récupération, la marge d'adaptation se réduit.



Plus les contraintes sont intenses, fréquentes et mal récupérées, plus la charge allostatique augmente et la capacité d'adaptation diminue.



Prévenir en agissant sur les facteurs modifiables et en favorisant la récupération.

Signes fonctionnels

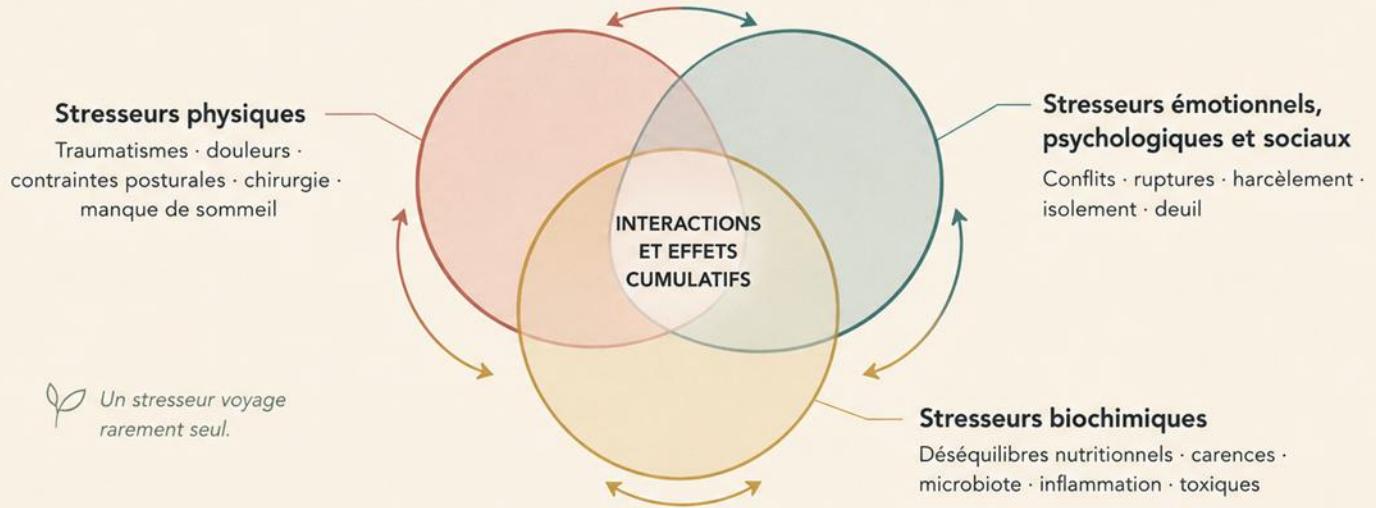


- fatigue
- troubles du sommeil
- douleurs
- tensions
- manifestations digestives

Parfois avant toute lésion anatomique identifiable.

La trilogie des stressseurs

Trois familles qui se croisent, s'accumulent et s'amplifient mutuellement

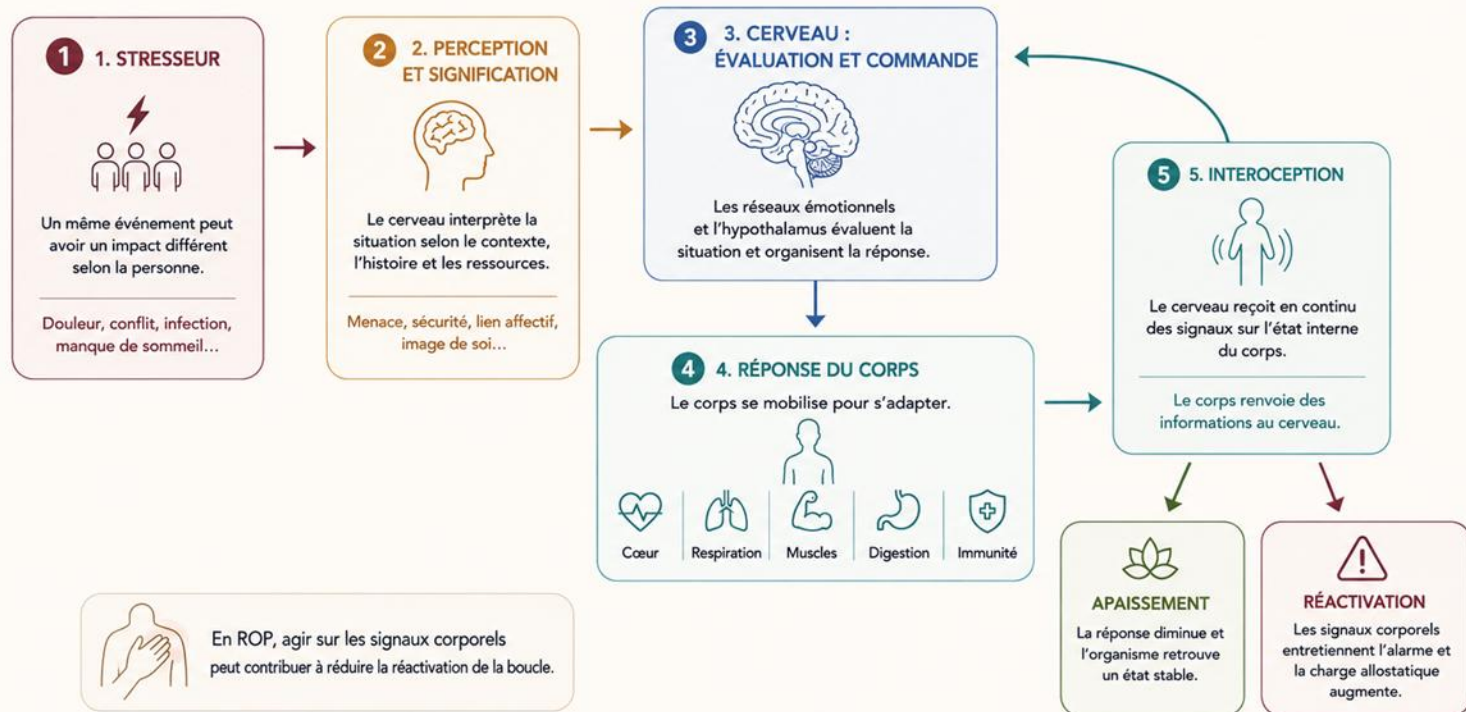


Répétition + récupération insuffisante → augmentation de la charge allostatique

Tant que les capacités d'adaptation et de récupération restent suffisantes, l'organisme absorbe les contraintes. Lorsqu'elles sont dépassées, fatigue, douleurs, troubles du sommeil ou manifestations digestives peuvent apparaître.

Le stress n'est pas l'événement, c'est la réponse

Le sens donné à l'événement et les signaux renvoyés par le corps modulent la boucle de stress.



La double réponse au stress : urgence et soutien

Une réponse rapide pour l'urgence, puis un soutien hormonal si la contrainte se prolonge.



Axe SAM

Réponse neurologique immédiate



Délai : secondes à minutes



Voie dominante : système sympathique, tronc cérébral, médullosurrénale

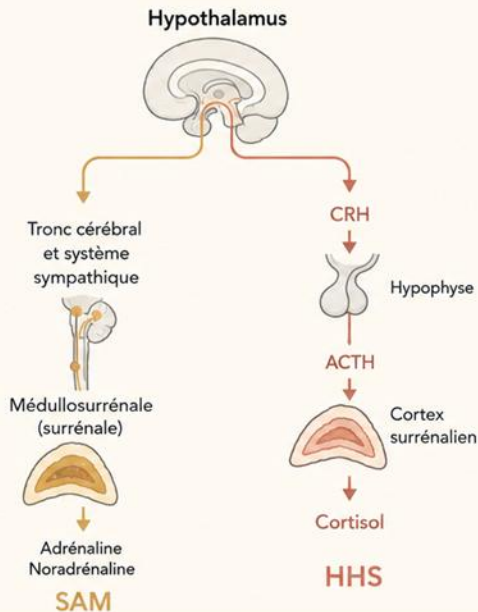


Médiateurs principaux : adrénaline, noradrénaline



Effets : fréquence cardiaque et ventilation augmentées, pression artérielle ajustée, glucose disponible, musculature prête à agir

Fonction : urgence, vigilance, action immédiate



Axe HHS

Réponse hormonale plus lente



Délai : minutes à heures



Voie dominante : hypothalamus → hypophyse → cortex surrénalien



Médiateurs principaux : CRH, ACTH, cortisol



Effets : maintien de la disponibilité énergétique, modulation immunitaire, soutien de l'adaptation dans la durée

Fonction : soutien prolongé de l'adaptation



Rétrocontrôle et clôture de la réponse

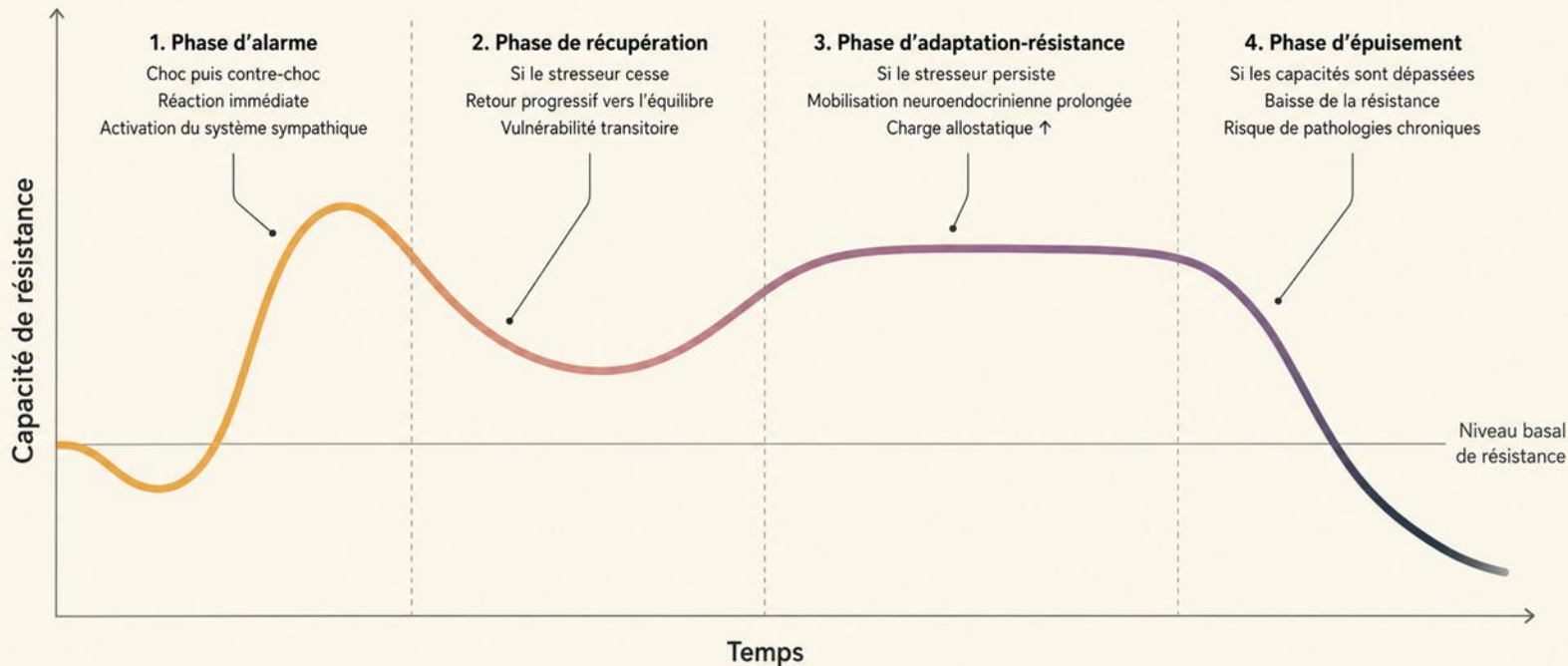
Quand le stressor disparaît ou que l'action l'a résolu, l'hippocampe, l'hypothalamus, l'hypophyse, les surrénales et les voies autonomes contribuent à réduire l'activation. Déclencher la réponse est vital ; savoir l'arrêter l'est tout autant.



Le cortisol est indispensable à la vie ; le problème vient surtout d'une activation excessive, prolongée ou inadaptée.

Le Syndrome Général d'Adaptation (SGA)

Lecture pédagogique inspirée
du modèle de Hans Selye



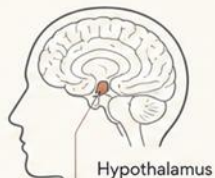
Le modèle classique décrit 3 phases ; cette lecture pédagogique en distingue 4 pour mieux visualiser la récupération.

De l'alarme à la récupération

Se mobiliser rapidement, puis redescendre lorsque la contrainte cesse.

1. Phase d'alarme

Mobilisation immédiate orientée vers l'action.



Hypothalamus



Système sympathique



Ressources dirigées vers l'action



Fréquence cardiaque et respiration augmentent



Glucose disponible, musculature prête à agir



Digestion et reproduction temporairement mises au second plan



Réponse protectrice si elle reste proportionnée et limitée dans le temps.



Si la contrainte cesse

2. Phase de récupération

L'organisme redescend et restaure son fonctionnement.



Restauration des gradients



Reconstitution de certaines réserves



Normalisation des rythmes cardiorespiratoires et métaboliques



Intégration de l'expérience



Fatigue passagère, besoin de sommeil ou baisse temporaire de performance



La récupération est variable d'un patient à l'autre.

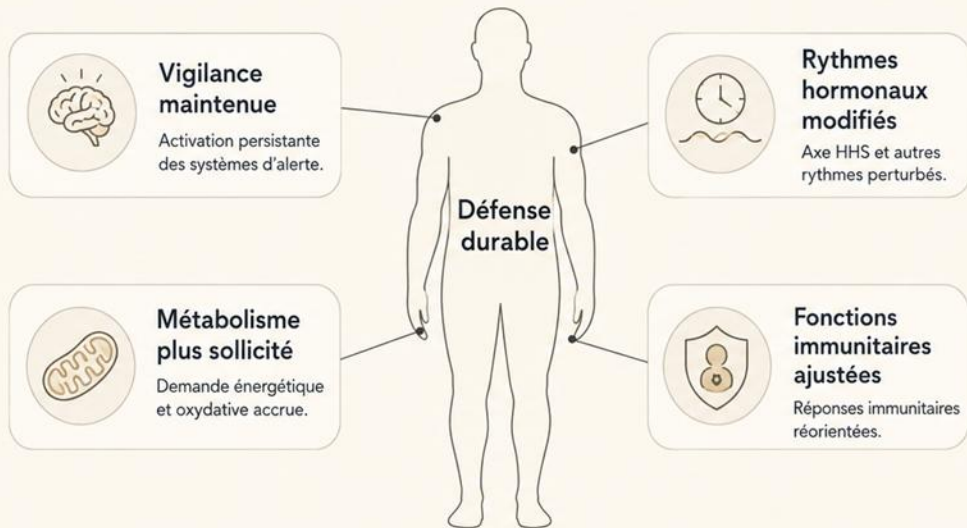


Pas de durée universelle

La récupération dépend de l'intensité de la mobilisation, de l'âge, de l'état de santé, du sommeil et des autres contraintes présentes.

Phase 3 : adaptation-résistance

L'organisme continue à tenir, mais au prix d'un coût de régulation croissant.



Manifestations fonctionnelles possibles

- Sommeil fragmenté
- Fatigue
- Troubles digestifs
- Douleurs
- Irritabilité
- Baisse de concentration
- Variations tensionnelles
- Perturbations métaboliques



Ces signes ne traduisent pas forcément une lésion irréversible.
Ils signalent souvent une réduction de la marge d'adaptation.



Le patient continue souvent à fonctionner,
mais il paie ce fonctionnement par
un coût de régulation croissant.

Phase 4 : Décompensation ou épuisement

La régulation devient moins souple et la vulnérabilité augmente.



La décompensation ne signifie pas que les surrénales sont « vidées ».

La fatigue surrénalienne n'est pas un diagnostic médical reconnu.

CONTRAINTES PROLONGÉES

- Stress répétés et prolongés
- Sommeil insuffisant ou fragmenté
- Douleur chronique
- Maladies ou infections persistantes
- Conditions sociales difficiles



TERRAIN ET FACTEURS MODULATEURS

- Susceptibilité génétique
- Âge
- Comportements et mode de vie
- Alimentation
- Traitements
- Activité physique
- Accès aux soins

MARGE D'ADAPTATION FORTEMENT RÉDUITE

Régulation autonome et hormonale moins souple

MANIFESTATIONS POSSIBLES



RÉGULATION DÉRÉGLÉE

Système nerveux autonome et axes hormonaux **moins souples** (stress, sommeil, humeur).



INFLAMMATION PERSISTANTE

Activation inflammatoire de bas grade maintenue dans l'organisme.



TROUBLES MÉTABOLIQUES

Métabolisme davantage sollicité : énergie, glycémie, poids, lipides, tension.



VULNÉRABILITÉ ACCRUE

Réserve fonctionnelle diminuée : plus grande sensibilité aux maladies et aux stress.

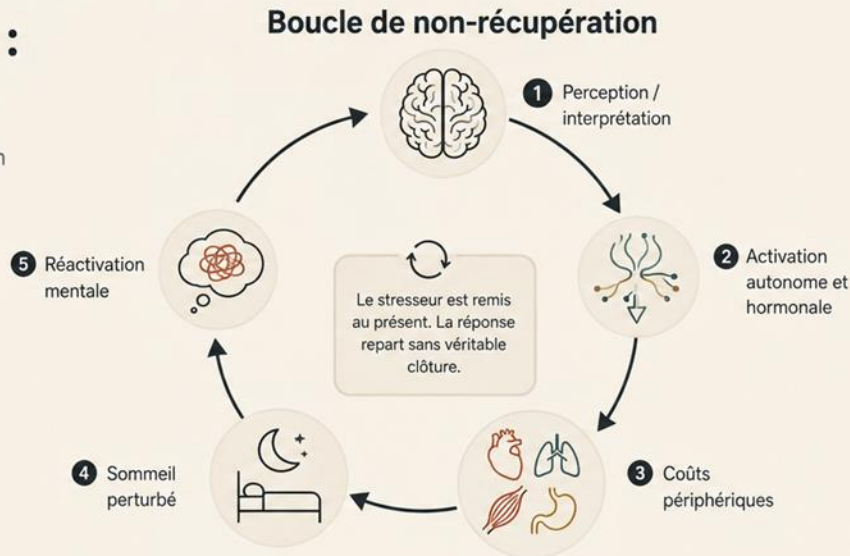


La progression vers la chronicité n'est ni automatique, ni causée par le seul stress.

Elle résulte de l'interaction entre contraintes, terrain biologique, mode de vie, maladies et contexte.

Le véritable coût du stress : l'absence de récupération

De la boucle de rumination à la boucle de non-récupération



Un événement intense peut être bien toléré si l'organisme agit, se régule puis récupère.



Une contrainte modérée devient coûteuse lorsqu'elle est réactivée chaque jour.



Ce qui compte n'est pas seulement la force du stress, mais la possibilité de terminer la réponse.

Coûts périphériques



Cœur :
activation cardiovasculaire prolongée



Muscles :
mâchoire, épaules, diaphragme, plancher pelvien



Respiration :
rythme plus rapide ou plus haut



Digestion :
motricité et inconfort viscéral modifiés

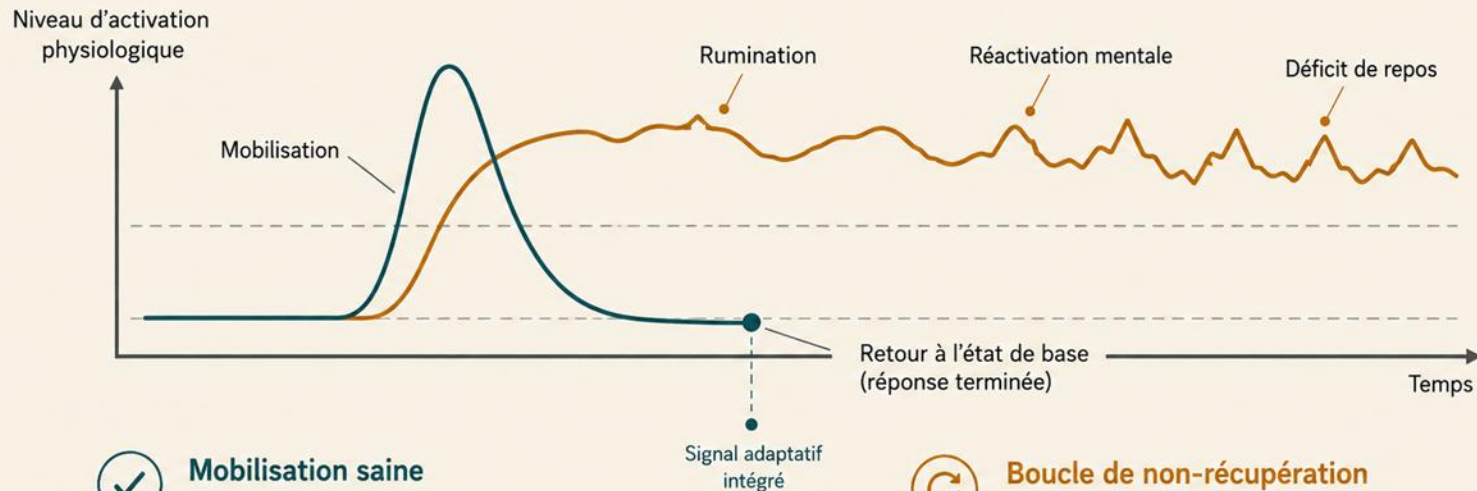


Immunité :
modulation répétée des réponses inflammatoires



La charge allostatique augmente lorsque la réponse est réactivée plus vite qu'elle ne se clôt.

L'enjeu adaptatif : pouvoir terminer la réaction



Mobilisation saine

Activation brève, proportionnée, suivie d'un retour à l'état de base. L'organisme récupère et se régule.



Boucle de non-récupération

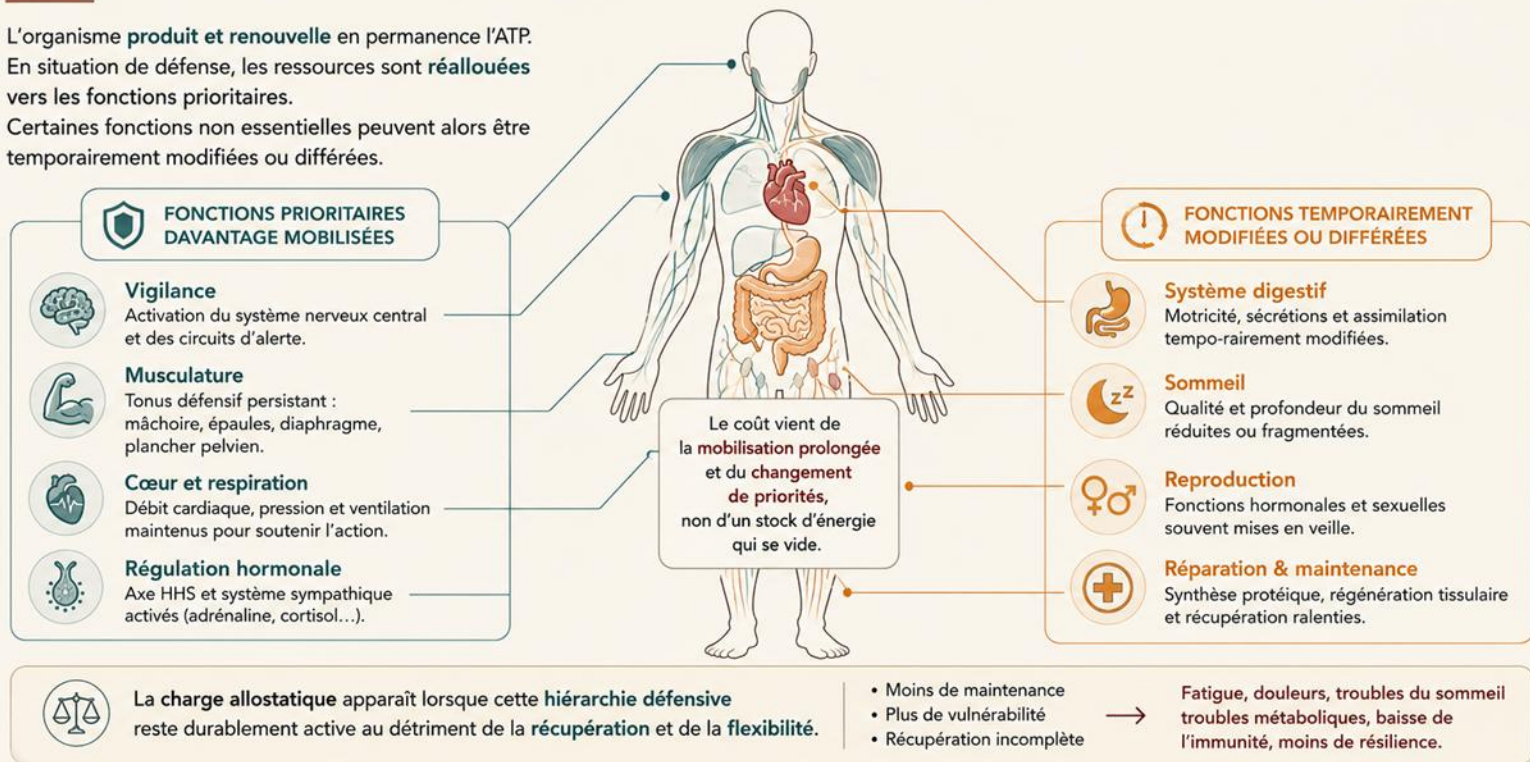
La réponse se prolonge ou se réactive avant sa clôture complète. Les stress s'accumulent sans retour complet à l'équilibre.



Thèse centrale : la santé adaptative dépend moins de l'absence de réaction que de la capacité de l'organisme à achever sa réaction.

Le coût de régulation : une mobilisation active, pas un réservoir percé

L'organisme **produit et renouvelle** en permanence l'ATP.
En situation de défense, les ressources sont **réallouées** vers les fonctions prioritaires.
Certaines fonctions non essentielles peuvent alors être temporairement modifiées ou différées.



La santé adaptative dépend de la capacité à achever cette régulation.

Le modèle du seuil : trouble fonctionnel et altération structurelle

Chronicité / contrainte croissante

Réversibilité décroissante

Fenêtre d'action ROP

marge fonctionnelle



Adaptation aiguë

Réponse proportionnée
Retour spontané à l'équilibre

Zone 1



Trouble fonctionnel

Alarme persistante
Récupération incomplète
Intégrité anatomique globalement préservée

Zone 2



Altération structurelle

Lésions, perte cellulaire
ou maladie installée
Réversibilité limitée

Zone 3



Réponse régulée.

L'organisme revient
spontanément à l'équilibre.



Marge fonctionnelle.

La ROP trouve ici sa place
la plus cohérente.



Pathologie structurelle.

La ROP accompagne le confort,
la douleur, le repos et la perception
corporelle, sans revendiquer
d'action curative propre.

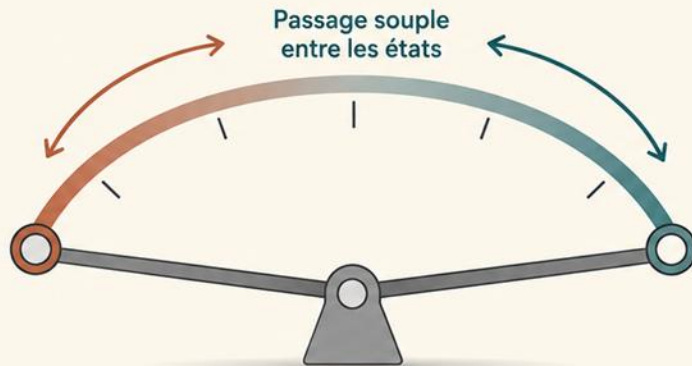
La cible autonome : la flexibilité

Pouvoir se mobiliser pour agir, puis revenir vers la récupération.

L'objectif n'est ni d'inhiber le sympathique ni de maximiser le parasympathique, mais de restaurer la capacité à passer doucement de l'un à l'autre.



Indispensable
à l'action



Indispensable
à la restauration



Flexibilité autonome

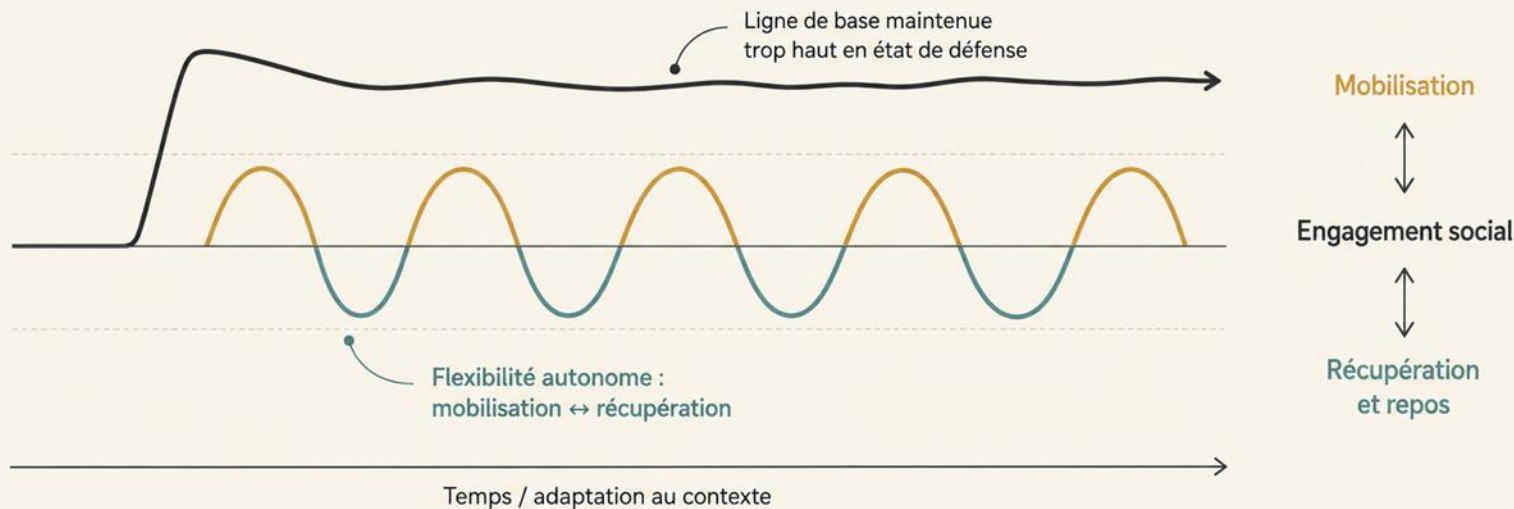
La santé réside dans la capacité
à passer doucement d'un état à l'autre.



Un organisme en bonne santé n'est pas un organisme toujours calme.
Il doit pouvoir se mobiliser rapidement, soutenir un effort, défendre son intégrité, puis revenir vers la récupération.

L'objectif autonome : la flexibilité, non la domination vagale.

La cible n'est pas de supprimer le système sympathique (nécessaire à l'action), ni de maximiser le tonus vagal. Il faut soutenir la capacité à circuler de manière appropriée entre mobilisation, engagement social et récupération.



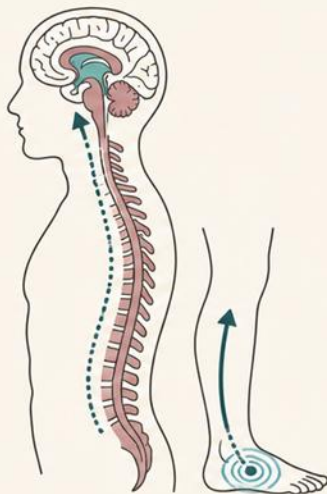
Pouvoir se mobiliser pour l'action, puis ne pas rester bloqué une fois le danger écarté.

La voie ascendante (Bottom-up) : informer l'intéroception

La ROP intervient dans la boucle intéroceptive qui entretient l'alarme.

Une stimulation tactile précise fournit des informations somatosensorielles nouvelles.

Le toucher transmet des informations du corps vers le cerveau.



La Chaîne d'Intégration



1. Toucher mesuré (environnement prévisible).

Stimulation tactile précise, adaptée et non agressive.



2. Signaux intéroceptifs de sécurité.

Informations somatosensorielles nouvelles transmises par les afférences corporelles.



3. Traitement par l'Insula et les réseaux limbiques.

Intégration dans les réseaux de l'interoception, du mode par défaut et associés à la douleur.



4. Modulation autonome (diminution du tonus défensif).

Modification possible de l'attention corporelle, de la perception de la douleur et du tonus défensif.



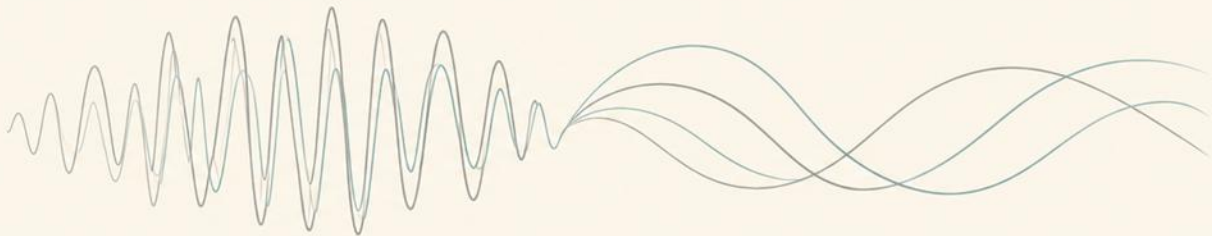
Note de recherche

Une étude en IRM fonctionnelle démontre que la réflexologie podale et un massage témoin modifiaient tous deux la connectivité de réseaux sensorimoteurs, du mode par défaut et associés à la douleur. Aucune différence spécifique entre les deux interventions n'a toutefois été démontrée chez les sujets sains. La spécificité des zones réflexes reste à préciser.



5. Descamps E, Boussac M, Joineau K, et al. Changes of cerebral functional connectivity induced by foot reflexology in a randomized controlled trial. Scientific Reports. 2023;13:17139. doi:10.1038/s41598-023-44325-x.

La séance ROP : stimuler, puis laisser intégrer



1. Évaluation tissulaire et clinique

Écouter, observer, examiner.

2. Sollicitation

Une information tactile précise et dosée.

3. Ne rien faire et laisser faire

Le temps d'intégration autonome.

Principe de dosage

Le meilleur stimulus n'est pas le plus fort.

C'est celui que le patient peut intégrer sans ajouter de charge à son système.

La séquence clinique ROP : une progression en quatre niveaux

Une trame adaptable, du signal d'alarme aux fonctions restauratrices

Niveau 1 • Crânio-cervical

Diminuer la persistance du signal.

Niveau 2 • Expression sympathique

Réduire la mobilisation devenue inutile.

Niveau 3 • Disponibilité respiratoire

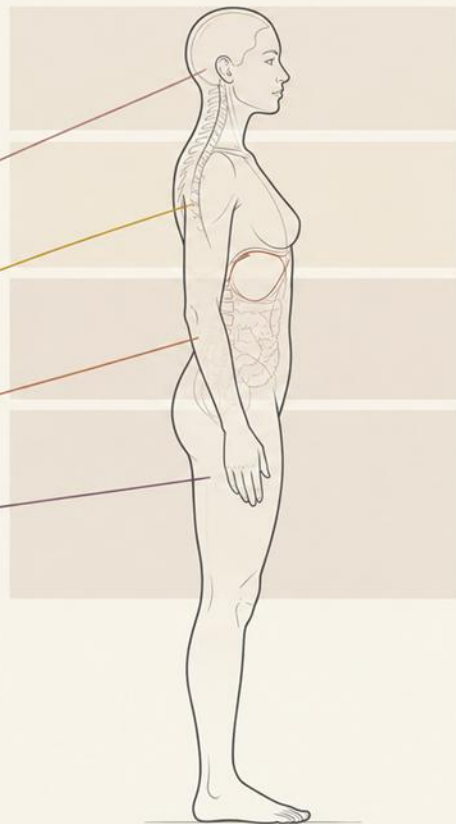
Restaurer la disponibilité respiratoire.

Niveau 4 • Fonctions viscérales

Permettre le retour des fonctions viscérales
et restauratrices.

*La séance ROP apporte une information sensorielle dosée ;
elle ne consiste pas à multiplier les stimulations.*

Cette progression constitue une trame clinique, non un protocole obligatoire
ni une causalité anatomique directe. Elle doit être adaptée au motif,
à l'évaluation et à la tolérance du patient.



Niveau 1 : Diminuer la persistance du signal

Une stimulation tactile mesurée propose une expérience corporelle stable, prévisible et sans exigence de réponse immédiate.

Objectif clinique : réduire la persistance du signal d'alarme et la vigilance tissulaire.



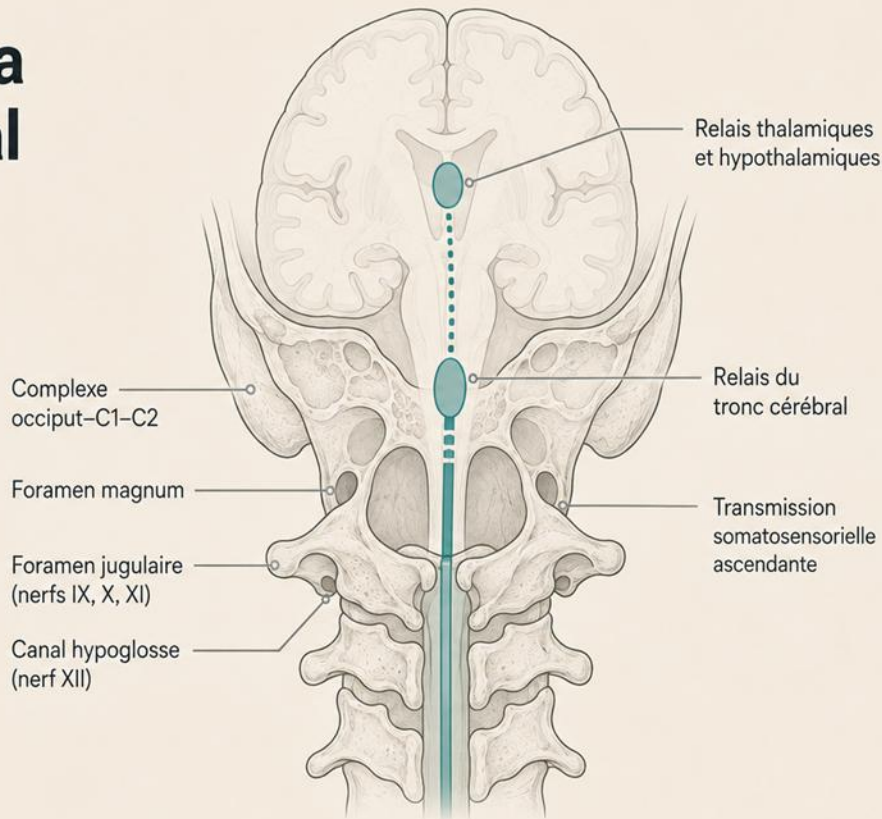
Repères ROP

zones occipitales · complexe occiput-C1-C2 · région du foramen magnum · région du foramen jugulaire · canal hypoglosse · nerfs IX, X, XI et XII



Limite d'interprétation

Ces repères ne signifient pas que le diencephale ou l'hypothalamus sont directement accessibles à la palpation.



Niveau 2 : Réduire la mobilisation devenue inutile

Lorsque le danger est passé, une mobilisation de défense peut persister. La sollicitation ROP accompagne son retrait sans inhiber le sympathique, indispensable à l'action.



INTENTION CLINIQUE

Favoriser la diminution du tonus de défense et le retour vers une ligne de base plus souple.



REPÈRES ROP

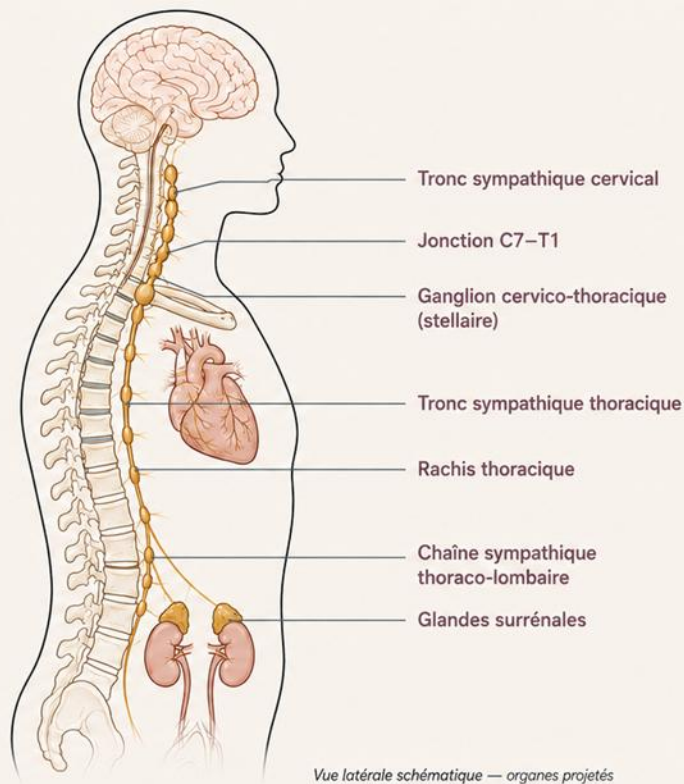
- Tronc sympathique cervical
- Jonction C7–T1
- Ganglion cervico-thoracique (stellaire)
- Tronc sympathique thoracique
- Rachis thoracique
- Chaîne sympathique thoraco-lombaire
- Glandes surrénales

Ces zones sont des repères réflexes utilisés pour accompagner la baisse d'une mobilisation devenue inutile.



LIMITE D'INTERPRÉTATION

Une modification de la tension, du ressenti ou de la respiration après la séance ne permet pas de conclure à une normalisation du cortisol, des catécholamines ou des axes SAM et HHS.



Offrir des informations tactiles compatibles avec le retrait progressif du tonus de défense lorsque l'action n'est plus nécessaire.

Niveau 3 : Restaurer la disponibilité respiratoire

Sous stress, la respiration peut devenir haute, rapide, irrégulière ou bloquée. Les tensions du diaphragme entretiennent les sensations d'oppression et les signaux corporels d'alarme.

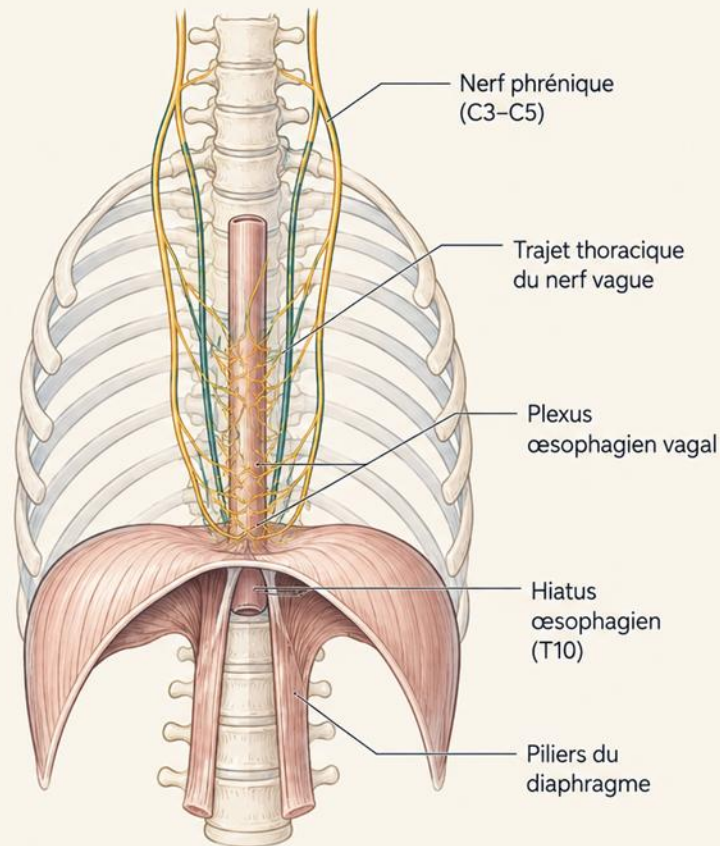
Favoriser une respiration plus libre, moins coûteuse et plus disponible.



Repères ROP : nerf phrénique C3–C5 ; diaphragme ; piliers ; hiatus œsophagien ; plexus œsophagien ; trajet thoracique du nerf vague.



Limite : les changements observés sont fonctionnels ; ils ne prouvent pas une action anatomique directe sur le phrénique, le vague ou les plexus.



Niveau 4 : Le retour des fonctions viscérales

Lorsque l'état d'urgence diminue, l'organisme peut de nouveau investir la digestion, l'assimilation, le repos et la réparation.



INTENTION CLINIQUE

Favoriser le retour des fonctions de maintenance et de la disponibilité viscérale.



REPÈRES ROP

- Voie vagale abdominale
- Plexus coeliaque
- Ganglions et plexus prévertébraux
- Nerfs splanchniques thoraco-lombaires
- Système nerveux entérique
- Plexus mésentériques
- Plexus hypogastriques
- Nerfs splanchniques pelviens S2-S4
- Zones viscérales associées

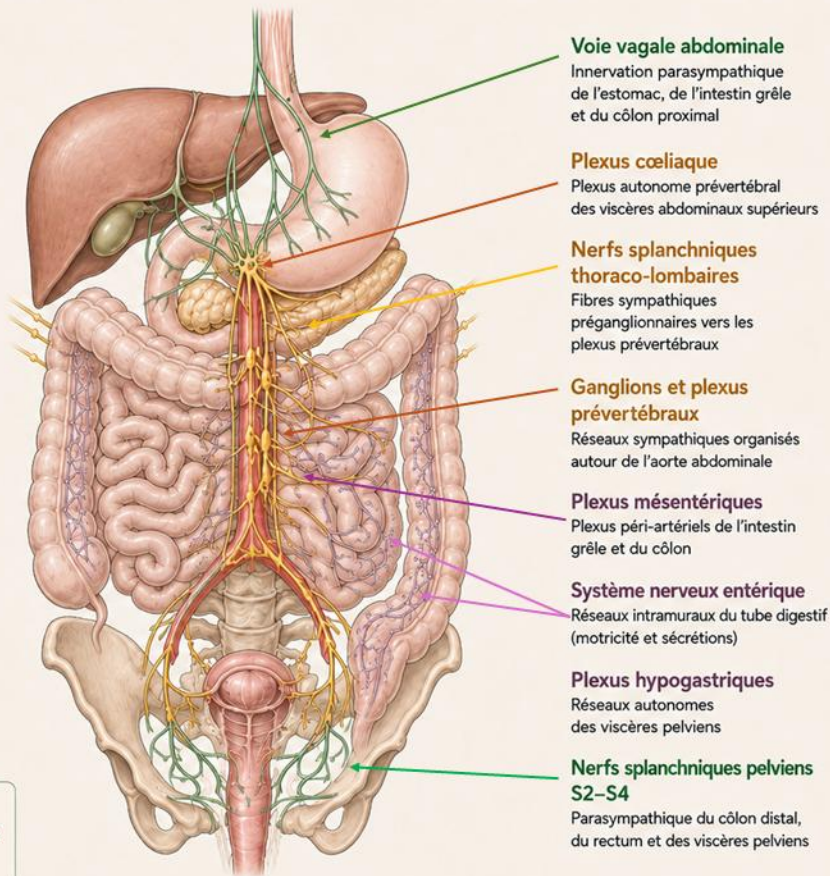


LIMITE D'INTERPRÉTATION

Les changements observés sont fonctionnels. Ils ne prouvent pas une action directe sur un organe ni une normalisation de sa physiologie.



Permettre la reprise des fonctions de digestion, d'assimilation, de sommeil, de réparation et d'immunité lorsque l'état de défense n'est plus au premier plan.



Voie vagale abdominale

Innervation parasympathique de l'estomac, de l'intestin grêle et du côlon proximal

Plexus coeliaque

Plexus autonome prévertébral des viscères abdominaux supérieurs

Nerfs splanchniques thoraco-lombaires

Fibres sympathiques préganglionnaires vers les plexus prévertébraux

Ganglions et plexus prévertébraux

Réseaux sympathiques organisés autour de l'aorte abdominale

Plexus mésentériques

Plexus péri-artériels de l'intestin grêle et du côlon

Système nerveux entérique

Réseaux intramuraux du tube digestif (motricité et sécrétions)

Plexus hypogastriques

Réseaux autonomes des viscères pelviens

Nerfs splanchniques pelviens S2-S4

Parasympathique du côlon distal, du rectum et des viscères pelviens

Fibromyalgie et charge allostatique

Une boucle de douleur, de sommeil perturbé et d'hypervigilance

La fibromyalgie associe plusieurs mécanismes : modulation de la douleur, sommeil, activité autonome, attention corporelle et facteurs individuels.

TABLEAU CLINIQUE



Douleur diffuse
et hypersensibilité



Fatigue
persistante



Sommeil non réparateur
ou perturbé

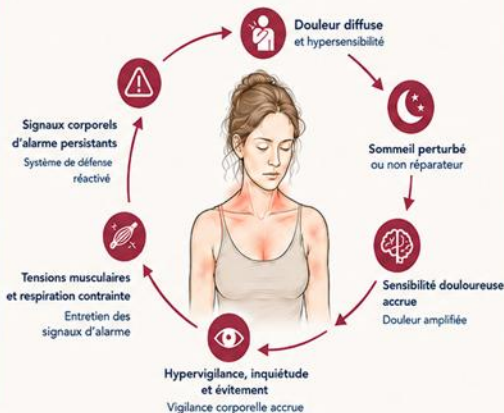


Difficultés cognitives
(attention, mémoire)



Sensibilité accrue au stress,
au bruit, à l'effort, au toucher

BOUCLE DE NON-RÉCUPÉRATION



CONDUITE ROP : PRINCIPES



Ne pas ajouter de charge.
Privilégier la douceur et la progressivité.



Stimulation douce, dosée et localisée.
Éviter les stimulations fortes ou étendues.



Réévaluer la réponse.
Observer dans les heures et les jours suivants.



S'ajuster en fonction de la tolérance.
Avancer par petites étapes.

OBJECTIFS CONCRETS



Améliorer le sommeil



Réduire la fatigue



Augmenter la tolérance
à l'activité



Diminuer la douleur



Mieux récupérer
après un effort



Améliorer la qualité
de vie

PROTOCOLE ROP PROPOSÉ

1

Cerveau limbique,
diencéphale, tronc
cérébral, hypophyse



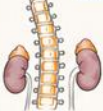
2

Nerf vague



3

Colonne vertébrale,
systèmes sympathiques,
surrénales



4

Diaphragme, plexus
solaire, foie,
intestins



5

Système crano-sacré :
nerf trijumeau, faux du cerveau
et tente du cervelet, compression
du 4e ventricule, SSB / S2

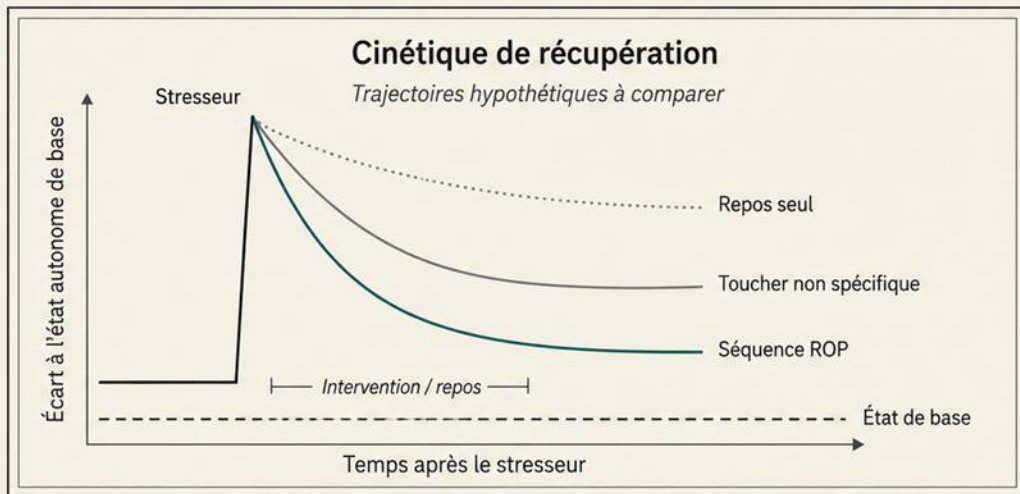


PRUDENCE CLINIQUE

Chez un patient hypersensible, stimuler davantage ne signifie pas traiter davantage.
La progression doit être lente et la réponse réévaluée régulièrement.

Vers la recherche : mesurer la cinétique de récupération

Tester si une séquence ROP standardisée accélère le retour à l'état autonome de base après un stressueur



Critère principal

Pente et durée de récupération



Méthode

ROP standardisée • toucher témoin • repos seul

Mesures à suivre

Physiologiques

- VFC / fréquence cardiaque
- Cortisol et alpha-amylase salivaires
- Conductance cutanée
- Amplitude respiratoire

Subjectives

- Stress perçu
- Tension corporelle
- Rumination / sentiment de sécurité

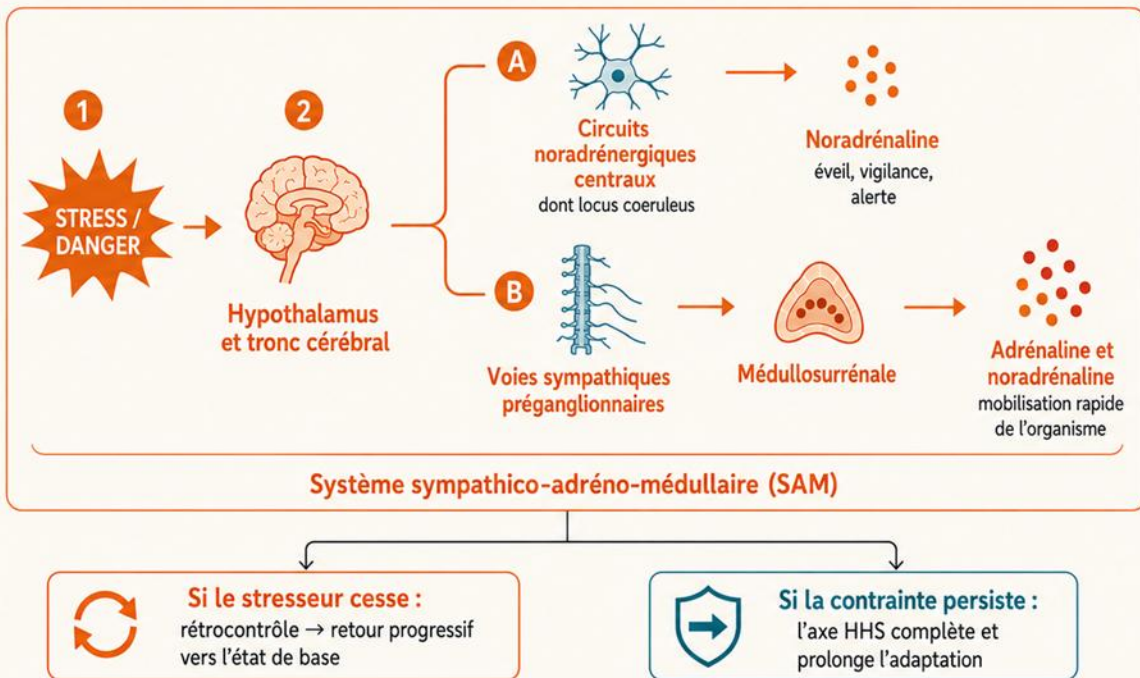
Suivi différé

- Sommeil
- Fatigue
- Douleur / récupération

L'enjeu n'est pas de supprimer la réaction de stress, mais de tester si la ROP aide l'organisme à la terminer plus rapidement et plus complètement.

Mécanisme de stress : réponse neurologique (SAM)

Réponse sympathico-adréno-médullaire rapide face au danger



Réponse globale du sympathique



↑ rythme cardiaque



↑ rythme respiratoire



↑ pression artérielle



↑ disponibilité du glucose



↑ afflux sanguin vers les muscles



Prépare à :
fuir, combattre ou se figer

Vigilance sensorielle renforcée



Vision



Audition



Olfaction

Fonctions mises au second plan



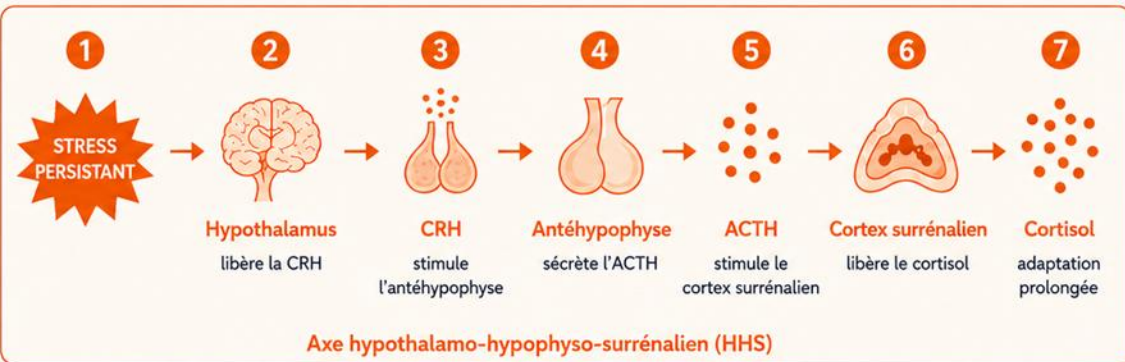
Système digestif



Reproduction

Mécanisme de stress : axe hormonal (HHS)

Réponse hormonale plus lente et durable face au stress persistant



Effets du cortisol



maintient la disponibilité énergétique



module la réponse immunitaire et inflammatoire



soutient l'adaptation dans la durée

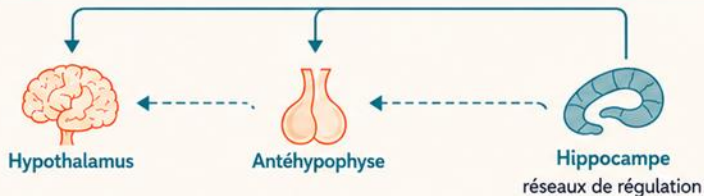


participe au rétrocontrôle

Le cortisol est indispensable à la vie ; le problème vient d'une activation excessive, prolongée ou inadaptée.

Feed-back / rétrocontrôle

Le cortisol freine la CRH et l'ACTH. Lorsque la contrainte cesse, la réponse diminue progressivement.



Réponse hormonale



réponse plus lente



plus durable



complète et prolonge la réponse SAM



Si la contrainte persiste, l'axe HHS complète et prolonge la réponse SAM.